

УДК: 616-006.6-08

Ж.К.Джарылкасинова

Жамбылский областной онкологический диспансер г.Тараз

Симптоматическая терапия при лечении онкологических больных

Аннотация. В данной статье описываются симптомы, которые появляются при опухолевых поражениях организма и при применении специфической терапии. Методы консервативного лечения этих симптомов и меры профилактики проявляющихся симптомов.

Ключевые слова: желудочно-кишечные нарушения, онкологические больные, симптомы.

Симптоматическая терапия при лечении онкологических больных имеет целью устранения наиболее тягостных проявлений заболевания, связанных с опухолью или с применением специфической терапии. Нежелательные симптомы не только ухудшают качество жизни больных, но зачастую представляют прямую угрозу для жизни. Одним из наиболее мучительных и опасных являются желудочно-кишечные симптомы, к которым относятся:

- тошнота и рвота,
- икота,
- диарея (реже запоры),
- мукозиты.

Наиболее опасным является их сочетание, приводящие к нарушению водно-электролитного баланса вследствие избыточного выделения жидкости и электролитов со стулом и рвотными массами, нарушенного всасывания в ЖКТ и ограничением приема пищи из-за болей в полости рта и пищеводе. Следствием таких нарушений могут быть кахексия и повышение риска развития инфекционных осложнений, ухудшение результатов специфического лечения.

Тошнота и рвота

Как известно, тошнота и рвота являются одним из наиболее частых симптомов у онкологических больных. Основными их причинами являются:

- распространение и рост опухоли в области ЖКТ, печени, центральной нервной системе,
- эметогенная лекарственная цитостатическая терапия,
- лучевая терапия в области ЖКТ, печени или головного мозга,
- терапия препаратами опиоидов,
- опухолевая интоксикация,
- запоры,
- инфекция или септицемия,
- почечно-печеночная недостаточность,
- гиперкальциемия,
- психический фактор,

Для оценки тяжести тошноты и рвоты наиболее удобной является шкала, разработанная Национальным раковым институтом США. Для оценки тошноты используются следующие критерии:

0 степень – тошнота отсутствует,

I степень – незначительно снижена возможность приема пищи,

II степень – значительно снижена возможность приема пищи, но больной может есть,

III степень – прием пищи невозможен,

IV степень –

Рвота оценивается согласно следующим критериям:

0 степень – тошнота отсутствует,

I степень – 1 эпизод рвоты на протяжении суток (24ч)

II степень – 2-5 эпизодов рвоты на протяжении суток,

III степень – 6 и более эпизодов рвоты на протяжении суток или необходимость внутривенной гидратации,

IV степень – необходимость парентерального питания или наличие осложнений, требующих интенсивной терапии; коллапс.

Рвота – это сложная реакция организма, в которой принимают участие центральная нервная система, ЖКТ, дыхательная мускулатура и мышцы брюшного пресса. Рвоте может предшествовать тошнота с неприятными субъективными ощущениями, появлением слюнотечения, мышечной слабостью, снижением артериального давления и анорексией.

Лечение тошноты и рвоты

Основными факторами, влияющими на выбор лечебной тактики тошноты и рвоты, являются:

- выявление причины, вызвавшей рвоту,
- определение основного механизма развития рвоты.

Для фармакологического воздействия применяются противорвотные препараты, кортикостероиды, седативные препараты и проводятся мероприятия направленные на коррекцию нарушений, вызванных рвотой.

Значение каждого из этих компонентов симптоматического лечения зависит от конкретной клинической ситуации.

Кроме того, в случае рвоты III или IV степени (по NCI) требуется достаточная гидратация больных в объеме до 1,5 -2 л/сут. Исключением является рвота при повышении внутричерепного давления, связанного с развитием как первичных, так и метастатических опухолей головного мозга. В этом случае лечение может быть эффективным лишь при условии активной дегидратационной терапии, направленной на декомпрессию головного мозга. Эти цели достигаются ограничением глюкокортикоидов (дексаметазон до 16-20 мг/сут) и введением мочегонных средств осмотического действия (10-20% раствор маннита 2г/кг). При симптомах выраженного обезвоживания после применения раствора маннита водный баланс восстанавливается капельными инфузиями изотонического раствора NaCl, для улучшения венозного оттока больному придают возвышенное положение, возможно проведение люмбальной пункции.

Патологическая икота

Икота, являясь результатом непроизвольных сокращений диафрагмы, одно из самых неприятных

осложнений, так как приносит больным со злокачественными новообразованиями длительные страдания. Причины возникновения икоты у этой категории больных могут быть следующие:

- прорастание опухоли в область диафрагмы,
- стеноз выходного отдела желудка (растяжение желудка),
- метастазы в печень,
- первичная опухоль головного мозга,
- уремия,
- раздражение диафрагмы и диафрагмального нерва близлежащими новообразованиями.

Первая помощь при патологической икоте заключается в глоточной стимуляции путем проглатывания сухого кусочка хлеба или небольшой порции алкоголя. Иногда помогает натуживание с закрытым ртом, кратковременные ингаляции CO₂, при стенозе выходного отдела желудка – аспирация содержимого желудка. Медикаментозное купирование патологической икоты достигается с помощью следующих препаратов:

- метоклопрамид (церукал, реглан) по 10-20 мг через каждые 6ч.
- диазепам (седуксен) 10мг 3-4 раза в сутки,
- аминазин 50мг внутримышечно 3-4 раза в сутки.

При икоте центрального генеза наиболее эффективен прием внутрь противосудорожных средств финлепсина по 0,2-0,4г или дифенина 0,1г до 3 раз в сутки.

При икоте, связанной с метастатическим поражением печени, обосновано кратковременное применение кортикостероидов (дексаметазон 8-10 мг внутримышечно по 2 раза в сутки).

Задержка стула

Запоры играют не последнюю роль в снижении качества жизни больных со злокачественными опухолями. Застой кишечного содержимого способствует усилению явлений интоксикации, развитию метеоризма, вызывающего боли в животе, тошнота, рвоты, анорексии и кахексии.

Основными причинами возникновения запоров являются:

Механические:

- стенозирование кишки врастающей в кишечную стенку опухолью органов малого таза;
- стенозирование кишки после лучевой терапии (язвенно-инфильтративные лучевые ректиты) или хирургического лечения;

Медикаментозная:

- нейротоксическое действие цитостатиков (винкаалкалоиды, эпопозид, цисплатин),
- систематическое употребление слабительных средств, стимулирующих перистальтику,
- применение наркотических анальгетиков.

Прочие:

- общее ослабленное состояние больного,
- постельный режим,
- нарушение диеты.

Лечение запора, если оно обусловлено причинами, требующими хирургического вмешательства, должно начинаться с назначения диеты, содержащей достаточное количество растительной клетчатки, кисломолочные продукты, растительное масло. Кроме того, при общем удовлетворительном состоянии целесообразны прогулки или незначительные физические нагрузки. В случае механических препятствий акта дефекации с хорошим эффектом применяют клизмы с гипертоническим раствором натрия хлорида, растительным маслом. При стойком запоре назначают очистительную клизму (объем жидкости не менее 2л). Основными противопоказаниями

для очистительных клизм являются наличие кровоточащих опухолей кишки и угроза перфорации. При тяжелых нарушениях моторики кишечника, вызванных цитостатиками назначают прозерин (0,015г 2 раза в день внутрь или по 1мл 0,05% раствора подкожно) с глютаминовой кислотой (0,5г по 4-6 раз в сутки), витамином B12 позволяет практически всегда добиться стула.

Диарея

Чаще диарея у больных со злокачественными заболеваниями возникает как осложнение противоопухолевого лечения: оперативных вмешательств (гастрэктомия, колэктомия), лучевой терапии и цитостатической терапии. Лекарственный энтероколит обусловлен прямым токсическим действием цитостатиков на эпителий тонкой и толстой кишки и развитием патогенной флоры на фоне, как правило, нейтропенической лихорадки.

Кроме того, другими причинами диареи у этой категории пациентов могут быть обострение сопутствующих заболеваний (хронический анацидный гастрит и энтероколит, дисбактериоз после антибактериального лечения, например, по поводу фебрильной нейтропении).

Симптоматическая терапия диареи онкологических больных осуществляется с учетом ее конкретного патогенеза и в общем виде заключается в назначении диеты, препаратов, уменьшающих перистальтику кишечника, противовоспалительных вяжущих средств, биологически активных веществ, нормализующих кишечную флору, антибиотиков.

Одним из общих принципов коррекции диареи является нормализация водно-электролитного баланса и процессов реабсорбции электролитов. Простейший и эффективный способ регидратации, позволяющий во многих случаях избежать парентерального введения растворов электролитов, является обильное питье смеси, состоящей из 1 чайной ложки поваренной соли, 1 чайной ложки питьевой соды, 4 столовых ложек сахарного песка, 1 стакан фруктового сока на 1 л воды, или официального препарата регидрона до 1,5л в сутки.

В медикаментозном лечении используются препараты, влияющие на моторику кишечника:

- лоперамид гидрохлорид (имодиум, энтеробэн) -4мг релос, затем по 2мг после каждого эпизода жидкого стула (не более 32мг в сутки),
- аттапульгит -2г после каждого эпизода жидкого стула.

Кроме того, при наличии болевого синдрома назначаются анальгетики, спазмолитики (но-шпа, платифиллин, баралгин). Дополнительными средствами лечения диареи могут быть калоформирующие сложные порошки на основе кальция карбоната, настои, отвары вяжущих средств растительного происхождения, биопрепараты (бактерин, бификол, ленекс).

Продолжающаяся более 48ч диарея требует введения синтетического аналога соматостатина – октреотида (сандостатин) 150 мкг x 3 раза в день подкожно, при присоединении лихорадки- назначение антибиотиков (интетрикс) и проведение инфузионной терапии для компенсации электролитных нарушений, предотвращения гиповолемии и шока.

Мукозиты

В качестве мер профилактики мукозита, которые можно ожидать с достаточной вероятностью при использовании цитостатиков, рассматриваются:

- полноценная санация полости рта перед циклами химиотерапии,
- криотерапия (рассасывание кусочков льда за 10-15 мин до и во время химиотерапии),
- систематический осмотр слизистой оболочки ротовой

полости.

При возникновении мукозита назначается терапия, направленная на купирование и ослабление субъективных симптомов, уменьшения воспаления, репарацию повреждений, профилактику инфекционных осложнений.

Предметом этой статьи явились основные, наиболее часто встречающиеся желудочно-кишечные осложнения у онкологических больных. Их своевременная профилактика и лекарственная коррекция представляют задачу, которая требует большого терпения, знания и опыта.

Список литературы

1. Гершанович М.Л., Пайкин М.Д. Симптоматическое лечение при злокачественных новообразованиях. 2-е изд. - М.: Медицина, 1986 - 285с.
2. Кондратьев В.Б.. Осложнения химиотерапии рака ободочной кишки и методы их лечения // Практич. онкол. - 2000. - №1. - С.31-36.
3. Ahmedzai S. Palliative care in oncology: making quality the end point // Ann. Oncol. - 1990 - Vol. 1. - P.396-398

Тұжырым

Ж.К.Джарылкасынова

Жамбыл ауданының онкологиялық диспансері

Онкологиялық науқастар емінің симптоматикалық терапиясы

Бұл мақалада ісіктің салдарынан ішкі ағзаларда болатын және арнайы емнен кейін пайда болатын клиникалық қасиеттер жазылған. Сол кездегі жүргізілетін консервативтік ем және алдын алу шаралары көрсетілген.

Түйінді сөздер: асқазан-ішек асқынуы, онкологиялық науқас, симптомдар.

SUMMARY

Z.S.Dzharylkasinova

Dzhambul Regional Oncology Center

The Treatment of cancer patients symptomatic therapy

It describes the symptoms that occur in cases of tumors of the body and application of a specific therapy. Methods of conservative treatment of these symptoms and prevention measures for symptoms that appear.

Keywords: gastrointestinal complications, cancer patients, symptoms.